

StrataXRT®

Para la prevención y el
tratamiento de la radiodermatitis

Un gran avance en la prevención y el tratamiento de la radiodermatitis



www.es.strataxrt.com

 **Stratapharma**
Iberia

Radiodermatitis: la desagradable consecuencia de una terapia que salva vidas

La radiodermitis es una reacción cutánea aguda que afecta aproximadamente al **95% de los pacientes** que reciben radioterapia en la mama, las ingles o el perineo.^{1,2,3} Por lo general, oscila entre el eritema y la descamación seca o incluso húmeda, y puede ser una fuente importante de dolor, malestar y angustia psicológica. En particular, la descamación húmeda plantea el riesgo de infección y puede dar lugar a interrupciones del tratamiento que perjudican los resultados del paciente.³

Hasta un 50-60% de los pacientes que reciben tratamiento contra el cáncer se someterán a radioterapia en alguna fase de su enfermedad.^{1,3,4}

La **quimioterapia** adyuvante aumenta considerablemente el riesgo de desarrollar lesiones cutáneas graves.⁵ La introducción de máquinas modernas de tratamiento de megavoltaje con capacidad para preservar la piel ha mejorado, pero **no eliminado** las toxicidades cutáneas.⁶

¿Cómo se valoran las terapias actuales?

Las revisiones sistemáticas sobre el tratamiento de la radiodermitis **no encontraron evidencia** que indicaran una diferencia entre el tratamiento farmacológico tópico y el tratamiento no farmacológico tópico en pacientes sometidos a radioterapia, excepto en el caso de los corticosteroides.^{7,8}

Los **corticosteroides** pueden provocar un adelgazamiento de la piel, lo que potencialmente puede causar deshidratación cutánea.⁹

Los estudios que evaluaron **lociones, cremas y emulsiones** (aloe vera, ácido hialurónico, etc.) no mostraron **ningún beneficio** en el tratamiento de la radiodermitis o proporcionaron pruebas contradictorias.¹⁰⁻¹²

Aunque existen pruebas iniciales que sugieren la eficacia de los apósitos a base de silicona^{13,14}, estos **apósitos sólidos** pueden presentar desventajas como tener algún efecto de bolus.¹⁵

Es esencial minimizar cualquier daño cutáneo garantizando que las intervenciones se basen en las mejores prácticas y en directrices basadas en la evidencia.²

Objetivos consensuados de la atención a las reacciones cutáneas durante la radioterapia ^{7,9,10}

Mantenimiento inicial de la integridad de la piel	✓	
Reducción del potencial de exacerbación de las reacciones cutáneas	✓	
Minimización de la pérdida de agua y optimización de la hidratación cutánea mediante agentes tópicos	✓	
Fomento de la comodidad y conformidad	✓	
Reducción del dolor y del prurito sin provocar efecto bolus	✓	
Control de hemorragias, olores y exudado excesivo	✓	(en combinación con apósito secundario)
Proporciona el entorno ideal para una reepitelización más rápida	✓	
Fomento de un entorno húmedo para la cicatrización de heridas en las que la piel está rota	✓	
Protección contra traumatismos y roces	✓	
Protección contra las infecciones	✓	

StrataXRT® está indicado a partir de la dosis inicial de radiación y durante toda la radioterapia hasta la recuperación completa de la piel

StrataXRT es un gel semioclusivo, autosecante y transparente. StrataXRT se seca para formar un apósito fino y flexible que hidrata y protege las zonas afectadas.

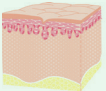
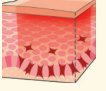
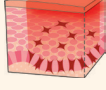
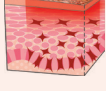
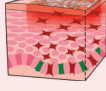
StrataXRT fue desarrollado para su uso sobre todos los tipos de radiodermitis, piel comprometida e intoxicada y heridas superficiales.

StrataXRT se emplea para aliviar los efectos inflamatorios de bajo grado como la sequedad, el picor, la descamación y la irritación.

En casos de efectos inflamatorios más severos, StrataXRT reduce el dolor, la rojez y el calor y ayuda a calmar las áreas expuestas de la piel.



La escala de RTOG para la radiodermitis

Puntuación de la escala RTOG	Observación: Signos externos	Observación: Nivel celular	Evaluación clínica	Objetivos del tratamiento	StrataXRT indicado para su uso
0			Sin cambios visibles en la piel	Mantener la piel suave, flexible, limpia, intacta y sin olores.	✓ 
1			Enrojecimiento e inflamación leve tirantez/picazón	Mantener la piel suave, flexible, limpia, intacta y sin olores, reducir la irritación y favorecer el confort.	✓ 
2			Piel sensible con rojeces brillantescon/sin descamación seca tirantez/picazón/dolor	Favorecer la hidratación y el confort de la piel y mantener la integridad de la piel. Reducir el picor, el dolor y las molestias.	✓ 
2.5			Descamación húmeda en parches Supuración moderada	Reducir el riesgo de complicaciones de nuevos traumatismos e infecciones. Reducir el dolor y las molestias.	✓ 
3			Descamación húmeda confluyente Exudación aguda	Reducir el riesgo de infección, minimizar el dolor y el traumatismo de la piel.	✓ 
4			Ulceración, hemorragia, necrosis	Desbridamiento de la herida. Control de las hemorragias y supuración (exudado), minimizar los efectos de la infección de la herida.	✓ 

Otras escalas de medición son RISRAS y CTCAE. El punto clave de medición en esta escala RTOG es el nivel 2,5 (2b), que denota el primer nivel de aparición de descamación húmeda. Fotos de varios pacientes. Imágenes (RTOG 0-3) cortesía de The Princess Royal Radiotherapy Review Team, St James's Institute of Oncology, The Leeds Teaching Hospitals NHS Trust. Tomado de la publicación "Managing Radiotherapy Induced Skin Reactions, a Toolkit for Healthcare Professionals".

StrataXRT® como prevención¹⁶

StrataXRT ayuda a preservar la integridad de la piel, reduciendo los efectos secundarios de la radiación ionizante.

- StrataXRT crea una película protectora que mantiene la integridad de la piel y reduce la fricción y la irritación de la zona afectada.
- StrataXRT se adhiere ligeramente al estrato córneo, protegiéndolo de la descamación excesiva.
- StrataXRT ayuda a prevenir las infecciones de la piel comprometida.
- StrataXRT proporciona una cobertura semioclusiva para una hidratación óptima de la zona dañada.
- StrataXRT reduce la respuesta inflamatoria aguda de la piel.
- StrataXRT no causa efecto bolus.^{17,18}

41,0% de reducción del riesgo de desarrollar toxicidad cutánea de grado 2.¹⁶

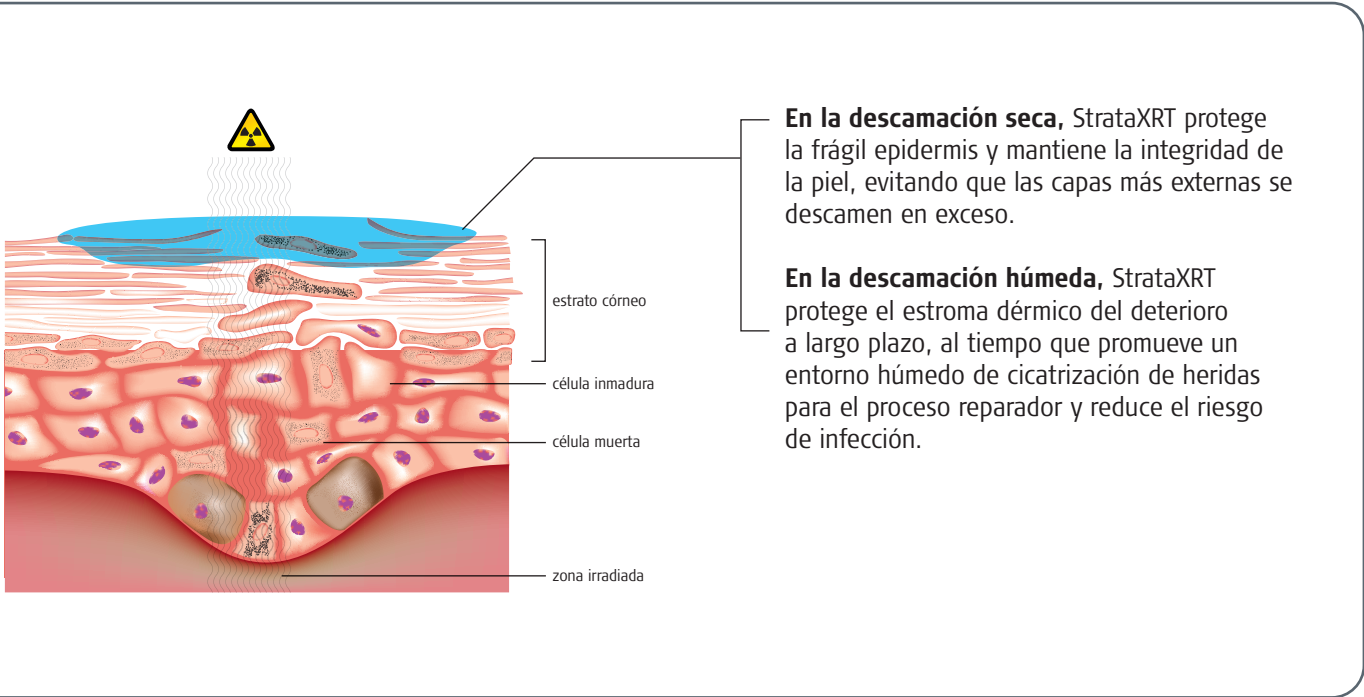
49,4% de reducción del riesgo de desarrollar toxicidad cutánea de grado 3.¹⁶

Utilizar inmediatamente después de la primera dosis de radioterapia.

StrataXRT® para el tratamiento de la radiodermatitis¹⁹

StrataXRT reduce la pérdida de agua transepidérmica (TEWL) promoviendo un entorno húmedo de cicatrización de heridas, lo que conduce a:

- Reepitelización más rápida de la piel tras el tratamiento
- Alivio de alteraciones cutáneas de bajo grado como sequedad, picor, descamación e irritación de la piel.
- Reducción del dolor, enrojecimiento y alivio de las zonas cutáneas expuestas.



¿Por qué StrataXRT® es un producto innovador?

- FORMA UNA PELÍCULA FLEXIBLE, DE CONTACTO TOTAL**
StrataXRT se seca para formar un apósito fino y flexible que garantiza un contacto constante con la piel.
- DESDE EL PRIMER DÍA**
StrataXRT puede aplicarse desde el primer día de radioterapia.
- SIN EFECTO BOLUS**
StrataXRT no provoca efecto bolus.^{17,18}
- CICATRIZACIÓN MÁS RÁPIDA DE LAS HERIDAS**
StrataXRT favorece un entorno húmedo de cicatrización de la herida que conduce a una reepitelización más rápida.
- ALIVIO SINTOMÁTICO**
StrataXRT proporciona un alivio sintomático de la sequedad, el picor, la descamación y la irritación de la piel, y reduce el dolor, el enrojecimiento y la sensación de calor.
- HIDRATACIÓN**
StrataXRT es semioclusivo y permeable a los gases, lo que permite que la piel comprometida y las heridas superficiales respiren y permanezcan hidratadas.
- PROTECCIÓN**
StrataXRT es bacteriostático, protege la piel de los agentes irritantes y de la invasión microbiana, al tiempo que reduce el riesgo de dermatitis de contacto.
- PARA DIFERENTES ÁREAS**
StrataXRT es adecuado para zonas de gran superficie y piel contorneada como los senos, la cara y el cuello, espalda y zona pélvica, así como articulaciones y zonas con vello sin necesidad de afeitado.
- NO REACTIVO**
StrataXRT no es reactivo, no tiene un pH medible, no contiene alcohol, parabenos o fragancias, lo que lo hace adecuado para niños y personas con piel sensible.
- APÓSITOS SECUNDARIOS**
Una vez seco, StrataXRT no impide que los apósitos secundarios o adhesivos se adhieran a la superficie de la piel.
- ADHESIÓN LIGERA**
StrataXRT se adhiere ligeramente a la capa más superficial de la piel dañada.

Reducción del riesgo con StrataXRT®

Un estudio de 197 pacientes realizado en Australia investigó los efectos de StrataXRT frente a la crema hidratante de glicerina 10% (Sorbolene) para prevenir y tratar la radiodermatitis en pacientes con cáncer de cabeza y cuello que recibían radioterapia radical.¹⁶

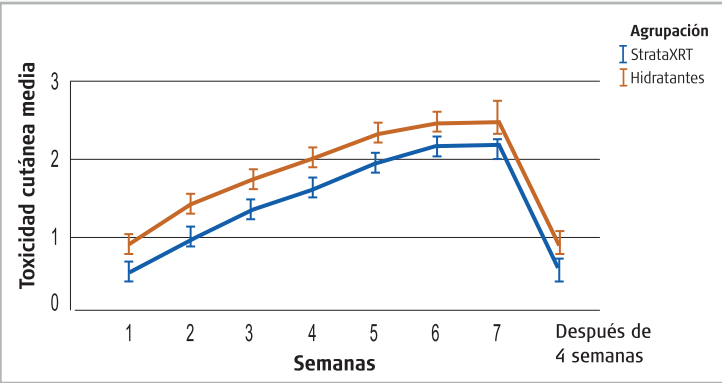
StrataXRT es superior a la crema hidratante en la **prevención y reducción de la gravedad** de la toxicidad cutánea:

- 41,0% de reducción del riesgo de desarrollar toxicidad cutánea de grado 2.
- 49,4% de reducción del riesgo de desarrollar toxicidad cutánea de grado 3.
- Menor toxicidad cutánea media al final del período de radioterapia.

StrataXRT es superior a la crema hidratante para **retrasar la gravedad** de la toxicidad cutánea:

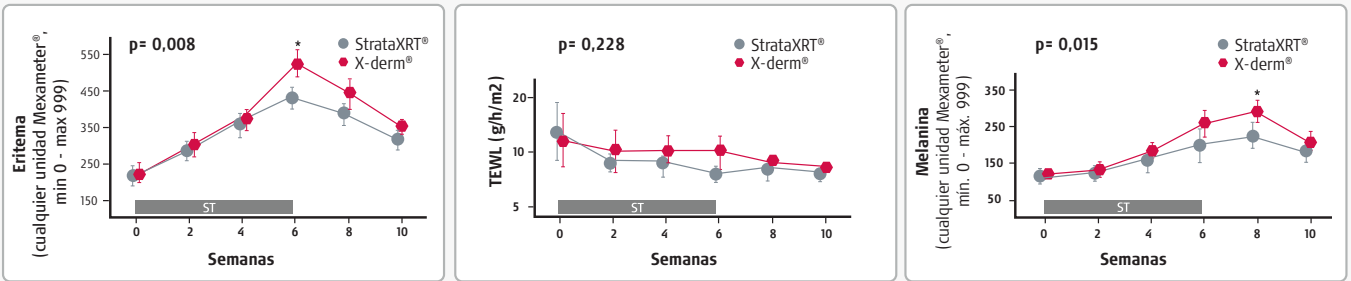
- Periodo más largo sin toxicidad cutánea de grado 3 con un 75% de pacientes que sobreviven 6 semanas.
- Mediana de 4 semanas para alcanzar el grado 2 de toxicidad en comparación con 3 semanas para la crema hidratante.

StrataXRT es **fácil de aplicar, aceptable, factible y eficaz** para pacientes con cáncer de cabeza y cuello, incluso en situaciones en las que vello corporal está presente.



En Corea del Sur se llevó a cabo un estudio con 56 pacientes en el que se asignó aleatoriamente pacientes que recibieron radioterapia en dos grupos, StrataXRT frente a una crema hidratante cosmética que contenía extractos de hierbas (X-derm).²⁰

Los pacientes de StrataXRT presentaban un nivel significativamente menor de eritema (21%) y de pérdida de agua transepidérmica (TEWL) (76%)* a las 6 semanas, así como cambios menores en la melanina (31%) a las 8 semanas, en comparación con el grupo de crema hidratante.



En España se llevó a cabo una serie de estudios de 5 pacientes para explorar el uso de StrataXRT para el tratamiento de la radiodermatitis **durante la quimioterapia concomitante**.⁵

Los pacientes que recibieron StrataXRT pudieron **continuar la terapia de forma ininterrumpida** en lugar de correr el riesgo de interrumpir el tratamiento debido al deterioro comúnmente esperado que se experimenta con la quimioterapia adyuvante.



Sesión de radiación 17
Inicio del tratamiento
con StrataXRT



Sesión de radiación 26
Tras 14 días de tratamiento
con StrataXRT



Sesión de radiación 30
Tras 21 días de tratamiento
con StrataXRT



Sesión de radiación 21
Inicio del tratamiento
con StrataXRT



Sesión de radiación 31
Tras 10 días de tratamiento
con StrataXRT



Post-radiación día 4
Tras 18 días de tratamiento
con StrataXRT

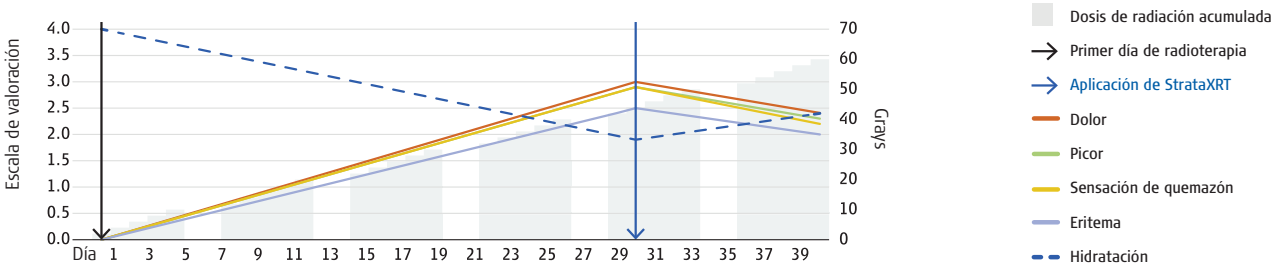
StrataXRT®, demostrado clínicamente para reducir la gravedad de la radiodermatitis durante la radioterapia

Un estudio multicéntrico de 54 pacientes realizado en España se centró en la eficacia de StrataXRT como apósito para heridas y como monoterapia en el tratamiento de la radiodermatitis.¹⁹

Inicio de la terapia con StrataXRT: Puntuación RTOG de $2,5 \pm 0,5$ en al menos el 25% de la zona irradiada (diferentes tipos de cáncer). Todos los pacientes fueron tratados con StrataXRT **mientras recibían radioterapia (RT)**. La experiencia clínica común es que la gravedad de la radiodermatitis aumenta con el tiempo y está proporcionalmente asociada a la radiación acumulada en los tejidos.

- Tras el inicio de la aplicación de StrataXRT, se observó una **mejora** del estado de la piel y de los signos y síntomas clínicos **durante la RT en curso**.
- El uso de StrataXRT muestra pruebas estadísticamente significativas de **reducción de la gravedad de la radiodermatitis** durante la RT en curso.
- La reducción de los marcadores de radiodermatitis **permite continuar con la radiación**, en lugar de interrumpirla debido a un aumento de la gravedad de la radiodermatitis.

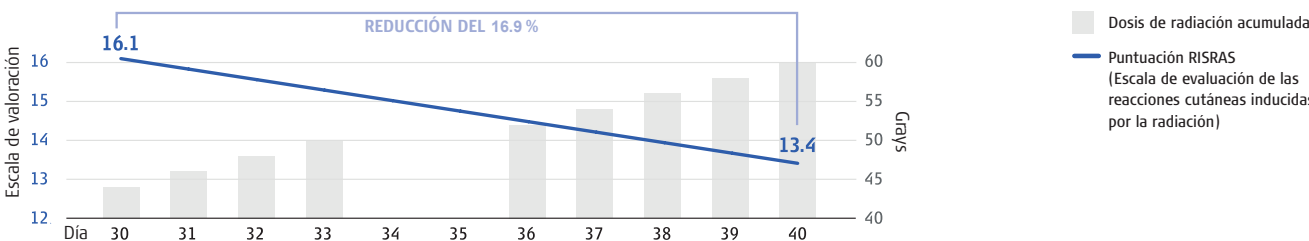
Medición de los signos y síntomas clínicos durante el tratamiento de radioterapia



Durante el periodo de tratamiento, StrataXRT mostró:

- Disminución del dolor en un 20,5%
- Disminución del picor en un 22,2%
- Disminución de la sensación de quemazón en un 24,7%
- Disminución del eritema en un 20,6%
- Mejora de la hidratación en un 26%

Evolución de la puntuación RISRAS durante el tratamiento de radioterapia y al aplicar StrataXRT



Aunque la radiodermatitis sólo debería de empeorar durante la RT y hasta aproximadamente 2 semanas después del final de la RT, StrataXRT mostró mejoría clínica:

- Disminución de la puntuación RISRAS en un 17% desde el inicio de la aplicación de StrataXRT hasta el final de la RT.
- Disminución de la puntuación RISRAS en un 37,6% desde el inicio de la aplicación de StrataXRT hasta 10 a 14 días después del final de la RT.

StrataXRT® frente a Mepitel Film®

StrataXRT demostró **no ser inferior a Mepitel Film®** en las medidas de resultado notificadas de descamación húmeda y peor grado de radiodermatitis aguda.²¹

StrataXRT es flexible y permite una **perfecta adaptación a las superficies corporales** en las que los apósitos físicos habituales resultan infructuosos o imposibles de utilizar, como las de gran movilidad (articulaciones), alta fricción (axila), piel húmeda (mucosa) y mayores necesidades higiénicas (perineo).⁵

También se observó que StrataXRT es más **fácil de usar** y **mejora la adherencia** del paciente en comparación con los apósitos físicos.²²

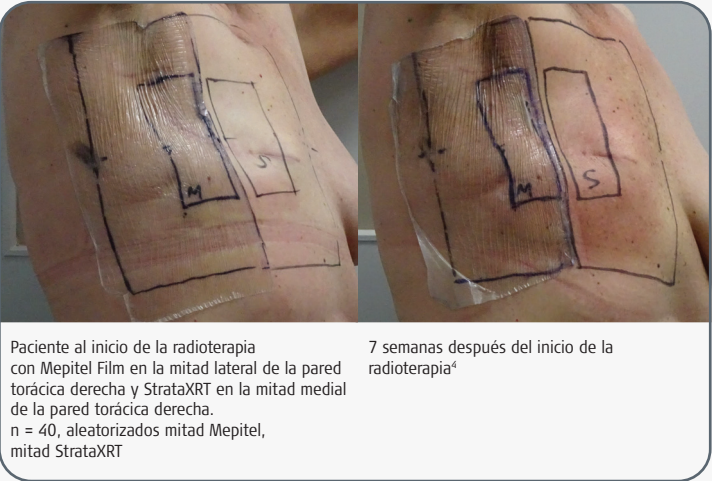
StrataXRT es una **opción más pragmática**, ya que Mepitel Film® amplía aún más la utilización de los escasos recursos de enfermería.

- El tiempo medio por aplicación de Mepitel Film® fue de 15 minutos (rango de 7,5-50 minutos).
- La aplicación de StrataXRT no requiere tiempo de enfermería, ya que se aplica por el propio paciente.²¹

StrataXRT permite al equipo de enfermería reducir tiempo y costes al **evitar apósitos físicos difíciles de fijar** (que llevan mucho tiempo) **y más costosos**. Sólo se necesita una pequeña cantidad de StrataXRT y la adherencia por parte de los pacientes mejoró, ya que StrataXRT es fácil de usar y transparente cuando se aplica.²²

StrataXRT no necesita ser retirado, lo que puede ser traumático para los pacientes cuando hay que que retirar y volver a aplicar los apósitos.¹⁹

Tres pacientes desarrollaron prurito con la película de Mepitel Film® y uno de ellos la retiró antes de tiempo.²¹



StrataXRT® Farmacoeconomía

Está clínicamente demostrado que StrataXRT **reduce la gravedad** de las reacciones cutáneas inducidas por la radiación, **minimizando las probabilidades** de no cumplir con la radioterapia planificada.¹⁹

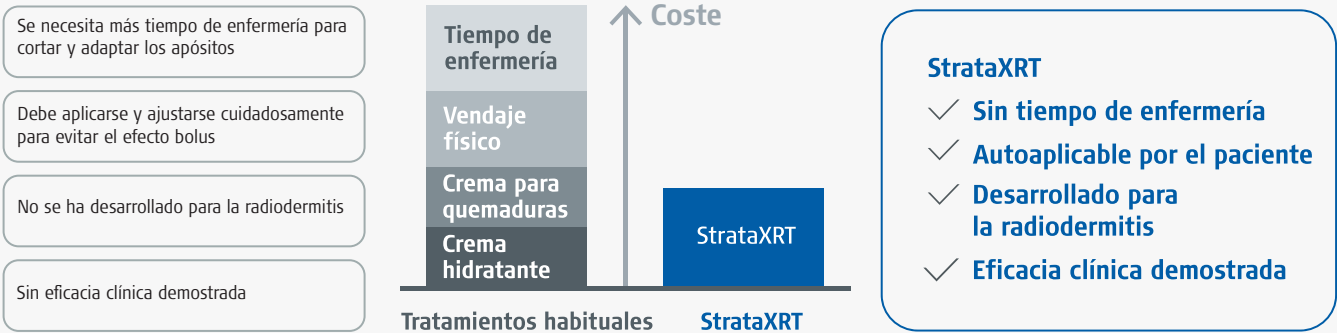
Una reducción de los pacientes con toxicidad cutánea relacionada con la radiación:¹⁹

- Favorecer mejores resultados sanitarios.
- Reducir los costes asociados a la interrupción de la radioterapia.
- Beneficiar la planificación y el uso de recursos de la unidad de radioterapia.

StrataXRT ha demostrado ser rentable en el tratamiento de la radiodermatitis:

- Un estudio reciente llevado a cabo en Australia, demostró un ahorro de coste por paciente de 760,24 dólares australianos con StrataXRT frente a las típicas cremas hidratantes por la prevención de radiodermatitis de grado 3.
- Los pacientes que usaron StrataXRT necesitaron menos servicios de enfermería para tratar la radiodermatitis.²⁴
- StrataXRT ha simplificado los protocolos de vendaje actuales, lo que significa que el tiempo medio dedicado a cada paciente se ha reducido considerablemente.²⁵
- Se ha confirmado que proporcionar un tubo grande de StrataXRT es rentable para prevenir la radiodermatitis grado 3.²⁴
- StrataXRT permite al equipo de enfermería evitar vendajes físicos más difíciles de solucionar, más costosos y que requieren más tiempo.²²

Costes generales del cuidado de la piel durante el tratamiento de radioterapia



Antes y después - Casos

Paciente en España de 64 años con un carcinoma bilateral, infiltración cutánea con adenopatías supraclaviculares y axilares múltiples. Antes de la radioterapia la paciente recibió 4 ciclos de adriamicina y ciclofosfamida + 12 ciclos de quimioterapia con paclitaxel. StrataXRT se aplicó en la mama izquierda y la terapia estándar en la mama derecha.²³

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, España



7 días después de la radioterapia. Inicio del tratamiento con StrataXRT



Tras 3 días de tratamiento StrataXRT



Tras 10 días de tratamiento con StrataXRT en ambas mamas

En Corea del Sur se realizó una serie de estudios para evaluar la eficacia de StrataXRT en pacientes con cáncer de cabeza y cuello.²⁶

- Se observó una mejora general con una reducción de los síntomas de picor y dolor.
- StrataXRT favorece un entorno húmedo de cicatrización de heridas para una reepitelización más rápida.
- Se observó una mejora general con una reducción de los síntomas de picor y dolor.



Inicio del tratamiento con StrataXRT



Tras 7 días de tratamiento con StrataXRT



Inicio del tratamiento con StrataXRT



Tras 3 días de tratamiento con StrataXRT

Antes y después - Casos



Sesión de radiación 21
Inicio del tratamiento
con StrataXRT

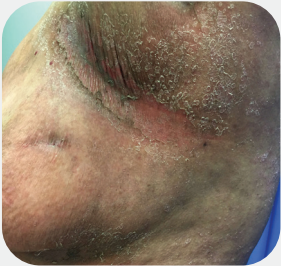


Día 2 tras radiación
Después de 13 días de
tratamiento con StrataXRT

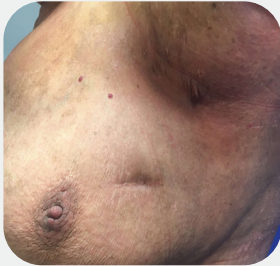


Día 18 tras radiación
Después de 29 días de
tratamiento con StrataXRT

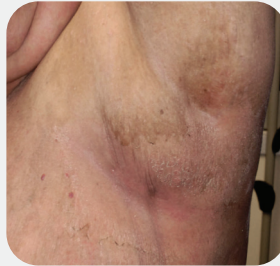
Neoplasia de parótida – Cara²⁷
Clínica IMQ Zorrozaurre,
Bilbao, España.



Sesión de radiación 19
Inicio del tratamiento
con StrataXRT



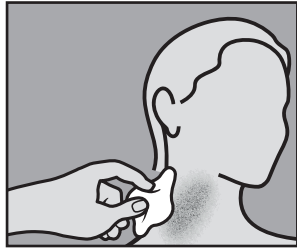
Día 6 después de la radiación
Día 7 usando StrataXRT



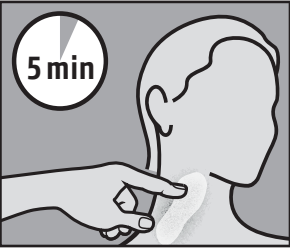
Día 13 después de la radiación
Día 14 usando StrataXRT

Neoplasia de mama²⁷
Clínica IMQ Zorrozaurre,
Bilbao, España

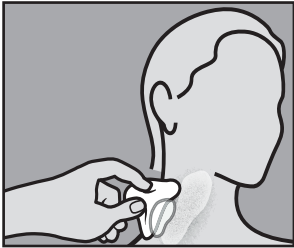
Instrucciones de uso



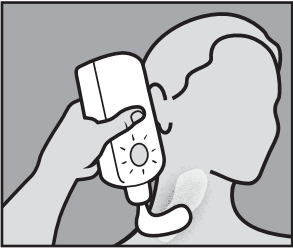
1. Asegúrese de que la piel o la herida superficial afectada esté limpia y seca. Secar suavemente tanto exceso de exudado o fluido de la herida como sea posible antes de la aplicación del gel.



2. Aplique **una capa muy fina** de StrataXRT directamente en la zona afectada y deje que el gel se seque. StrataXRT debería estar seco en **5-6 minutos**.



3. Si tarda más en secarse, probablemente se ha aplicado demasiado. Retire suavemente el exceso con un pañuelo limpio o una gasa y permita que el proceso de secado continúe.



4. Una vez seco, StrataXRT puede cubrirse con protector solar, cosméticos y ropa.

Instrucciones adicionales

- StrataXRT debe aplicarse una o dos veces al día en las zonas afectadas o según sea necesario para mantener el contacto con la superficie afectada.
- StrataXRT puede ser **reaplicado más a menudo** para asegurar el contacto constante con la piel, o para reducir los síntomas.
- El lavado probablemente eliminará la StrataXRT. Vuelva a aplicar StrataXRT **después de cada lavado**.
- Áreas con **mayores necesidades higiénicas** (ingle, perineo, anal): StrataXRT debe aplicarse después de cada micción y evacuación intestinal, en piel seca y limpia.
- Para obtener los mejores resultados StrataXRT debe mantenerse en **continuo contacto con la piel** (24 horas al día, 7 días a la semana).
- StrataXRT **no necesita ser retirado** antes de la radioterapia.
- StrataXRT puede utilizarse con o sin un apósito protector secundario.
- StrataXRT **no necesita ser frotada o masajead**, ya que no penetra por debajo del nivel del estrato córneo (la capa superior de la piel) y no aumentará su efecto.
- StrataXRT puede ser aplicada directamente sobre la piel, usando el dedo, Q-tip, etc.

Consejos para el uso de StrataXRT®

- StrataXRT puede almacenarse en el refrigerador antes de su aplicación para un alivio más rápido de la sensación de ardor que puede producirse después de la radioterapia.
- Si no se seca completamente, StrataXRT puede manchar la ropa. El lavado normal no eliminará el producto de la ropa. Si aun así se mancha, la mancha, la limpieza en seco debería ser suficiente para quitarlo sin dañar el tejido.

StrataXRT® y otros productos

Hidratantes, lociones, cremas para quemaduras, etc. no son necesarias. StrataXRT puede volver a aplicarse más a menudo para evitar la sensación de piel seca y tirante, ya que StrataXRT evita la evaporación del agua a través de la piel dañada que puede causar esta sensación. Se pueden aplicar cremas hidratantes y cremas para quemaduras después de que StrataXRT se seque para mantener el primer contacto de StrataXRT con la piel. A diferencia de StrataXRT, las cremas hidratantes pueden causar irritación, y la mayoría de las cremas para quemaduras son totalmente oclusivas (significa que no permiten el intercambio de gases a través de la piel). Añadir cualquier producto adicional sobre StrataXRT puede reducir la eficacia de StrataXRT.

StrataXRT reduce la necesidad de antibióticos.

StrataXRT es bacteriostático y previene la invasión bacteriana sin riesgo de dermatitis de contacto.

StrataXRT reduce la necesidad de corticosteroides.

StrataXRT reduce la respuesta inflamatoria aguda de la piel sin los efectos secundarios de los corticosteroides.

IMPORTANTE

Debido a la naturaleza semipermeable de StrataXRT:

- StrataXRT puede potenciar el efecto de un ingrediente activo si StrataXRT se aplica sobre el ingrediente activo.
- StrataXRT puede impedir o reducir la absorción de ingredientes activos si se aplican sobre StrataXRT.

Apósito secundario. StrataXRT no absorbe el exudado. En caso de descamación húmeda, StrataXRT debe utilizarse en combinación con apósitos absorbentes. StrataXRT debe ser la primera capa de contacto con la piel. StrataXRT no necesita secarse antes de aplicar el apósito secundario.

Duración recomendada del tratamiento

StrataXRT se recomienda como profilaxis **tras la dosis inicial de radiación** y debe seguir aplicándose durante un mínimo de 60-90 días (24 horas al día/7 días a la semana) **después de la radioterapia**, o hasta que no se observe ninguna mejoría. Para la radiodermatitis crónica, se recomienda el uso continuado hasta que no se observe ninguna mejoría.

Cuánto StrataXRT® se necesita

El gel StrataXRT es una formulación única que requiere una **cantidad sustancialmente menor de producto** por aplicación que las cremas o geles habituales.



StrataXRT 20 g

Contiene suficiente gel para más de 2 semanas de tratamiento durante un plan de fraccionamiento estándar* aplicando el gel 2 veces al día.

C.N.: 192576.3



StrataXRT 50 g

Contiene suficiente gel para más de 5 semanas de tratamiento durante un plan de fraccionamiento estándar* aplicando el gel 2 veces al día.

C.N.: 192577.0

* Se considera fraccionamiento estándar 5 días por semana. Se esperan 2 semanas post radiación para el pico de toxicidad y 2 semanas más para la recuperación de la piel. Por lo tanto, el tiempo de terapia estándar puede prolongarse hasta 2 semanas.

StrataXRT® - un gran avance en la prevención y el tratamiento de la radiodermatitis

StrataXRT:

- Puede aplicarse tras la dosis inicial de radiación mientras dure la radioterapia y hasta la recuperación completa de la piel
- No provoca efecto bolus
- Reduce significativamente la respuesta inflamatoria aguda de la piel
- Reduce el dolor, el enrojecimiento y la sensación de calor
- Alivia la piel seca, con picores, descamación e irritación
- Favorece una curación más rápida
- Protege e hidrata todo tipo de radiodermatitis, pieles tóxicas y comprometidas
- Es bacteriostático, reduciendo el riesgo de infección
- Es inerte, no contiene alcohol, parabenos ni fragancias



Para consultas o pedidos: Email: es.pedidos@stratpharma.com | Teléfono: +34 659 100 762

www.es.strataxrt.com

Precaución: Lea siempre la etiqueta, utilice sólo según las indicaciones. Sólo para uso externo. StrataXRT no debe entrar en contacto con los ojos. StrataXRT no debe aplicarse sobre medicamentos tópicos a menos que se lo indique su médico. StrataXRT puede manchar la ropa si no está completamente seca. Si se mancha, la limpieza en seco debería poder eliminarlo sin dañar el tejido. Para una correcta conservación, vuelva a cerrar bien el tubo con el tapón. Si su dermatitis por radiación muestra signos de infección o no se cura después de 30 días de la aplicación inicial del producto, consulte a su médico. Si se produce irritación, interrumpa el uso y consulte a su médico. No es adecuado para heridas muy exudativas, heridas tunelizadas o quemaduras de 3er grado. Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar después de la fecha de caducidad (EXP) impresa en el tubo. La fecha de caducidad (EXP) no cambia una vez abierto el tubo. No utilizar si el tubo está dañado. Estéril hasta su apertura. StrataXRT no requiere métodos especiales de eliminación. Siga las normas locales de eliminación. **Composición:** Polidimetilsiloxanos, siloxanos, alquilmetilsiliconas.

Referencias: 1. Porock, D., Kristjanson, L. (1999). *European Journal of Cancer Care*, 8, pp. 143-153. 2. Kedge, EM. (2009). *Radiography*, 15, pp. 247-257. 3. Naylor, W., Mallett, J. (2001). *European Journal of Oncology Nursing*, 5(4), pp. 221-233. 4. Lopez, E., et al. (2002). *Breast Cancer Research and Treatment*, 73, pp. 127-134. 5. Villandiego, IA. (2018). *Journal of Cancer Therapy*, 9, pp. 1048-1056. 6. Hymes, S., et al. (2006). *J Am Acad Dermatol*, 54(1), pp. 28-46. 7. Ho, AY, et al. (2018). *Int J Radiat Oncol Biol Phys*, 101, pp. 325-33. 8. Ferreira, EB, et al. (2017). *Support Care Cancer*, 25, pp. 1001-11. 9. Barnes, L., et al. (2015). *Drug Saf*, 38, pp. 493-509. 10. Boldeston, A., et al. (2006). *Support Care Cancer*, 14, pp. 802-817. 11. McQuestion, M. (2006). *Seminars in Oncology Nursing*, 22(3), pp. 163-173. 12. Wickline, MM. (2004). *Oncology nursing forum*, 31(2), pp. 237-244. 13. Herst, M., et al. (2014). *Radiother Oncol*, 110, pp. 137-43. 14. Wooding, H., et al. (2018). *Br J Radiol*, 91(1081); doi: 10.1259/bjr.20170298. 15. Diggelmann, KV, et al. (2010). *Br J Radiol*, 83, pp. 971-978. 16. Chan et al., (2019). *Radiotherapy and Oncology*, 139, pp. 72-78. 17. Data on file, 2018 (Dr. J. Ekeberg, University Hospital Basel, Basel, Switzerland). Stratpharma AG. 18. Data on file, 2017 (A. Walsh, ROC, Springfield, Australia). Stratpharma AG. 19. Quilis, A., et al. (2018). *Journal of Radiation Oncology*, 7(3), pp. 255-264. 20. Ahn, et al. (2020). *In Vivo*, vol. 34 (1), pp. 413-422. 21. Data on file, 2019 (Chao, M. Austin Hospital, University of Melbourne, Australia). Stratpharma AG. 22. Data on file, 2015 (Ribes, J.L. Institut Català d'Oncologia Barcelona, Spain). Stratpharma AG. 23. Data on file, 2015 (Hospital Universitario de Fuenlabrada, Hospital Ruber Internacional, Madrid, Spain). Stratpharma AG. 24. Data on file, 2019 (Blades, R et al, Brisbane, Australia). Stratpharma AG. 25. Data on file, 2015 (Rodríguez C. Oncology Institut Group of Madrid (IMO) Madrid, Spain). Stratpharma AG. 26. Data on file, 2015 (Hee-Jung Kim, Seoul, Republic of Korea). Stratpharma AG. 27. Data on file, 2016 (S. Gonzalez Aramberri, I. Arranz Villandiego). Stratpharma AG.

Fabricado por: Stratpharma AG, Aeschenvorstadt 57, CH-4051 Basilea, Suiza
Stratpharma Iberia SL: Po de la Castellana, 216 - 8a Planta (Torre Realía), 28046 Madrid, Espana